

EUTHANASIE – 1/2

« Étymologiquement : une bonne mort. En pratique, le mot ne sert guère que pour désigner une mort délibérément acceptée ou provoquée, avec l'aide de la médecine, pour abréger les souffrances d'un malade incurable : c'est une mort médicalement assistée. Le mot, qui fut lui aussi compromis dans l'abjection nazie, s'en sort pourtant mieux que celui d'« eugénisme ». C'est sans doute que l'euthanasie, à condition qu'elle soit strictement contrôlée, pose moins de problèmes : d'abord parce qu'elle ne concerne que des individus, point l'espèce elle-même ; ensuite, et surtout, parce qu'elle ne vaut que pour des malades incurables, qui l'ont expressément demandée (euthanasie volontaire) ou dont les proches, si les malades ne peuvent s'exprimer, l'ont demandé à leur place (euthanasie non volontaire). J'y vois un progrès plus qu'un danger. Quand la médecine ne peut nous guérir, pourquoi ne nous aiderait-elle pas à mourir ? Le danger n'en existe pas moins, qui est celui d'une élimination systématique des malades les plus lourds. Raison de plus pour qu'une loi, comme il convient dans un État de droit, vienne fixer des limites et imposer des contrôles. »

→ **André Comte-Sponville, *Dictionnaire philosophique* — (2001)**

EUTHANASIE – 2/2

« Le Comité Consultatif National d'Éthique vient de relancer le débat sur l'euthanasie, autrement dit sur la mort médicalement assistée. Son avis, sans avoir force de loi, pèse lourd : cette institution officielle de la République est tout à fait dans son rôle – éclairer l'opinion publique et le législateur – en intervenant sur cette question difficile. Il était temps. Les trois quarts d'entre nous mourront en milieu hospitalier. Cela donne aux médecins une responsabilité qui, sans être tout à fait nouvelle, ne cesse de s'accroître : non seulement combattre la maladie, tant que c'est possible, mais aussi nous accompagner dans nos derniers instants – qui peuvent durer, hélas, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Non seulement nous aider à vivre, tant que nous le pouvons, tant que nous le voulons, mais nous aider à mourir, lorsque la souffrance ou la déchéance deviennent insupportables et vaines.

Rappelons d'abord quelques évidences. Il est clair que l'acharnement thérapeutique est une horreur, dont nous ne voulons plus. Les médecins ont aujourd'hui les moyens de nous maintenir en vie, s'ils le souhaitent, presque indéfiniment. Mais à quoi bon, si cela n'ajoute à notre vie qu'une agonie interminable ? Quand la médecine ne peut plus nous guérir, quand elle ne peut prolonger notre vie qu'au prix de souffrances atroces, il est évidemment préférable qu'elle s'abstienne, et laisse la mort, faute de mieux, nous délivrer. La médecine est au service de la santé. Elle n'est pas là pour faire durer indéfiniment la maladie.

Il est clair aussi que les soins palliatifs sont aujourd'hui une exigence prioritaire, d'ailleurs prévue par la loi, et qu'il importe de satisfaire au plus vite. Nos médecins disposent, contre la douleur, de traitements formidablement efficaces. Il est inadmissible qu'ils renoncent parfois à les utiliser, soit par manque de moyens financiers (notamment en personnel), soit par désintérêt (parce que les soins palliatifs seraient une activité secondaire, scientifiquement peu prestigieuse, médicalement peu exaltante, économiquement peu rémunératrice), soit enfin par

crainte d'abrèger la vie du patient. C'est un contresens sur la médecine, dont le propre n'est pas de guérir (elle ne le peut pas toujours), ni d'empêcher de mourir (elle ne le peut jamais définitivement), mais de soigner. L'accompagnement des mourants fait partie de sa vocation la plus haute, qui est d'aider la vie jusqu'à son terme.

Ces deux évidences, toutefois, ne suffisent pas à régler la question de l'euthanasie. Certes, renoncer à l'acharnement thérapeutique, c'est souvent accepter une euthanasie passive. On laisse mourir, délibérément, celui qu'on ne pourrait maintenir en vie, au prix d'un traitement très lourd, que dans des conditions inhumaines. Cette euthanasie passive est aujourd'hui bien acceptée : dans un service de réanimation, environ 50% des décès en relèvent, et nul ne songe, hormis quelques intégristes, à le reprocher aux médecins. Mais c'est l'euthanasie active qui fait problème : non celle qui laisse mourir, mais celle qui tue.

Le progrès des soins palliatifs tend à en diminuer la demande. Lorsqu'on ne souffre plus, pourquoi aurait-on envie de mourir ? Mais il n'y a pas que la souffrance physique. Il n'y a pas que les maladies en phase terminale. Il y a le handicap extrême, et qui peut durer toute une vie, la dépendance absolue, le malheur insurmontable. Il y a les déficiences sensorielles, la perte progressive de ses capacités intellectuelles, l'immobilité obligée, l'asphyxie, l'isolement, le refus d'être à la charge de ses enfants ou de la société, l'ennui, l'angoisse, l'humiliation, la lassitude, l'épuisement, le dégoût de soi et de tout... Vouloir quitter la vie, dans ces conditions, ce n'est pas la trahir ; c'est protéger une certaine idée que l'on s'en fait.

Ce n'est pas une question de dignité. L'association qui en a fait son mot d'ordre principal et son sigle (ADMD : Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité) a toute ma sympathie, mais se trompe sur ce point. Si tous les hommes sont égaux en droits et en dignité, cette dernière ne saurait varier selon les circonstances, fussent-elles atroces. En quoi un polyhandicapé ou un grabataire sont ils moins dignes de respect qu'un valide ? En rien, bien sûr. En quoi leur dignité les protège-t-elle de l'horreur ? En rien non plus. Ce n'est pas une question de dignité, mais de liberté. Suis-je ou pas maître de ma vie ? Que les Églises répondent non, c'est leur droit, que je respecte, mais qui ne saurait s'imposer aux laïques. Or, si je suis maître de ma vie, j'ai le droit d'y mettre fin (le droit de s'en aller, quand on n'en peut plus, fait partie des droits de l'homme), comme on a le droit de m'y aider si je suis hors d'état, seul, d'y parvenir.

Par exemple celui qui est paralysé des quatre membres. S'il veut vivre, il a toute mon admiration. Mais celui, dans la même situation, qui veut mourir, je ne vois pas ce que je pourrais lui reprocher, ni pourquoi il me serait interdit, si je suis son médecin, de l'aider.

L'euthanasie active et volontaire – ce qui suppose qu'elle a été expressément demandée par le malade – est alors une assistance au suicide. C'est peu dire qu'elle me paraît tolérable ; il devient de plus en plus intolérable, me semble-t-il, de refuser de l'envisager.

Le Comité d'éthique, sans vouloir la légaliser tout à fait, demande que la loi prévoie « une exception d'euthanasie ». La formule est heureuse. Il est clair que la règle, pour la médecine, c'est le respect de la vie humaine. Mais cela peut justifier, parfois, qu'on l'interrompe, quand elle ne pourrait continuer que dans l'horreur. L'euthanasie est alors une exception, en effet, qui confirme la règle : respecter la vie humaine, c'est aussi lui permettre de rester humaine jusqu'au bout. »

→ Comte-Sponville, *Le goût de vivre et cent autres propos* (2010), « Euthanasie »